

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

SIGNIFICANT EVENT ANALYSIS E ROOT CAUSE ANALYSIS PATIENT SAFETY

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO092_00	00	30/04/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Risk Manager Clinico + RSGI	AD – Francesco Epifani	Riservato Alta Direzione + Direttore Sanitario	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e ambito

La presente procedura definisce il processo di Significant Event Analysis (SEA) e Root Cause Analysis (RCA) per gli eventi avversi e i near miss che impattano la sicurezza dei pazienti di Toscana Diagnostica S.r.l. La procedura è in attuazione di ISO 7101:2023 §10.2, della Raccomandazione Ministero Salute n. 19, e si applica a tutti gli eventi classificati nel registro TD-SGI-MOD209 con esito "Moderate Harm" o superiore, oltre a tutti gli eventi sentinella e a un campione di near miss selezionati per learning.

Ambito: tutti i processi clinici di TD - accettazione, esecuzione esami, refertazione, consegna referti.

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
ISO 7101:2023 §10.2	Improvement (CAPA Patient Safety)
Raccomandazione Min. Salute n. 19	RCA in sanità
DM 11/01/2024 (SIMES)	Notifica obbligatoria eventi sentinella
TD-SGI-MOD209	Tassonomia ICPS - input al SEA/RCA
TD-SGI-MOD210	Cruscotto KPI Patient Safety - output del SEA/RCA
TD-SGI-PLN005	Piano obiettivi rischio clinico
TD-SGI-PRO070	NIS2 - per eventi avversi con cyber-correlation
WHO Multi-causal model + Reason model (Swiss Cheese)	Modelli di analisi

3. Trigger del SEA/RCA

Tipologia evento	RCA obbligatoria?	Tempistiche
Sentinel Event	Sì	Avvio entro 24h - completamento entro 30 giorni - notifica SIMES
Adverse Event con Severe Harm	Sì	Avvio entro 72h - completamento entro 30 giorni
Adverse Event con Moderate Harm	Sì	Avvio entro 7gg - completamento entro 60 giorni
Adverse Event con Mild Harm	Su decisione Risk Manager Clinico	Standard 60-90 gg
No Harm Incident con potenziale rilevante	Su decisione	Avvio settimanale - completamento 60-90 gg
Near Miss ricorrente (≥ 3 eventi simili in 6 mesi)	Sì - per cluster	Avvio entro 30gg - completamento 90gg
Reclamo paziente con elementi di safety	Su decisione	Standard

4. Metodologia

TD adotta una combinazione di metodologie di RCA, scelte in funzione dell'evento:

Metodologia	Quando applicarla	Output
5-Whys	Eventi semplici, near miss, RCA rapida	Catena causale lineare
Ishikawa (Fishbone)	Eventi con multiple cause potenziali (uomo, macchina, metodo, materiale, ambiente,	Diagramma causa-effetto

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

	misura)	
Reason Swiss Cheese Model	Eventi sentinella, eventi sistemici	Identificazione delle barriere mancanti / forate
Fault Tree Analysis	Eventi tecnologici con sistemi complessi (LIS, AI)	Albero degli errori
London Protocol	Eventi con coinvolgimento clinico complesso	Analisi multi-livello

5. Procedura operativa

Fase	Attività	Owner	T target
1. Trigger	Evento qualifica per RCA da MOD209 §3	Risk Clinico Manager	T0
2. Convocazione team RCA	Composizione del team multidisciplinare (RM Clinico, Direttore Sanitario, Direttore Lab/Imaging coinvolto, RSGI, eventuale operatore coinvolto)	Risk Clinico Manager	T0+24h (sentinel) - T0+72h (severe)
3. Raccolta dati	Cartella paziente, referto, log LIS/RIS, registrazioni, intervista operatori, evidenze materiali	Team RCA	T0+7gg
4. Ricostruzione cronologica	Timeline puntuale dell'evento	Team RCA	T0+10gg
5. Identificazione cause prossimali	Cosa è andato storto direttamente	Team RCA	T0+15gg
6. Identificazione cause root	Perché è andato storto - applicazione metodologia (§4)	Team RCA	T0+20gg
7. Identificazione delle barriere mancanti	Quali controlli avrebbero potuto prevenire l'evento - perché non hanno funzionato	Team RCA	T0+25gg
8. Formulazione CAPA	Azioni correttive (rimozione delle cause root) e preventive (rinforzo barriere mitigative)	Team RCA	T0+25gg
9. Reporting al Risk Manager Clinico + AD	Report di RCA con cause, CAPA, owner, scadenze	Team RCA	T0+30gg (sentinel) - T0+60gg (severe) - T0+90gg (moderate)
10. Open Disclosure (se applicabile)	Comunicazione al paziente/famiglia - coordinata con DPO e Legale	Direttore Sanitario	Senza ingiustificato ritardo dopo accertamento
11. Notifica SIMES (se sentinella)	Trasmissione obbligatoria al Ministero Salute	Direttore Sanitario	Coerentemente con DM 11/01/2024
12. Aggiornamento procedure / formazione	Revisione documenti SGI alla luce delle CAPA	RSGI + owner di processo	Entro 60gg dal report

13. Verifica efficacia CAPA	Audit di follow-up dopo 90gg dall'implementazione	Risk Clinico	Manager	+90gg da CAPA chiusa
14. Aggiornamento MOD209 e MOD210	Chiusura evento nel registro + impatto sui KPI	Risk Clinico	Manager	Costante

6. Cultura del giusto colpevolizzare (just culture)

TD adotta il principio di "just culture" promosso da WHO e ISO 7101: gli operatori sono incoraggiati a segnalare eventi avversi senza timore di sanzioni, salvo casi di:

- (a) violazione consapevole di procedure - responsabilità disciplinare;
- (b) negligenza grave o dolo - responsabilità individuale;
- (c) eventi attribuibili a errore umano in contesti a rischio - approccio sistemico, formazione, revisione delle procedure.

Questo è formalizzato nella Politica integrata POL001 e nel Codice Etico (in adozione).

7. KPI di processo

KPI	Target
% RCA completate entro le tempistiche	≥ 90%
% CAPA implementate entro le scadenze	≥ 90%
% CAPA verificate per efficacia a 90gg	100%
Tempo medio dal trigger alla chiusura RCA	≤ 60gg
% eventi sentinella notificati a SIMES nei tempi	100%
Numero RCA condotte/anno	Tracciato (target dipende dal volume eventi)
Riduzione anno-su-anno di eventi avversi simili (post-CAPA)	Tracciato

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	30/04/2026	Prima emissione della Procedura SEA/RCA Patient Safety in Area 07 Rischio Clinico in attuazione di ISO 7101 §10.2 e Raccomandazione Min. Salute n. 19. Adotta 5 metodologie RCA (5-Whys, Ishikawa, Reason Swiss Cheese, FTA, London Protocol) con criteri di applicazione differenziati. Trigger automatici per Sentinel Event, Severe Harm, Moderate Harm. Coordinamento con SIMES Ministero Salute. Chiude la NC P1 #19 del RPT003.	Risk Manager Clinico + RSGI	AD